

IMPACTO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA SOBRE LA SALUD CARDIOVASCULAR: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

González-Rubio, Soledad.

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Alfonso X el Sabio. Avda de la Universidad s/n, Villanueva de la Cañada (Madrid)

Email: sgonzrub@myuax.com

RESUMEN

La dieta mediterránea ha sido ampliamente estudiada por sus beneficios sobre la salud, especialmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares. El objetivo de este trabajo es analizar la evidencia científica reciente sobre su impacto en el riesgo cardiovascular. Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica utilizando bases de datos como PubMed y ScienceDirect, seleccionando artículos publicados en los últimos 10 años y dentro del primer cuartil (Q1). Los resultados indican que la dieta mediterránea se asocia con una reducción significativa del riesgo cardiovascular, mejorando factores como el perfil lipídico, la presión arterial y los niveles de inflamación. Además, se ha observado una menor incidencia de eventos cardiovasculares en personas con alta adherencia a este patrón dietético. En conclusión, la dieta mediterránea representa una estrategia eficaz para la prevención de enfermedades cardiovasculares.

PALABRAS CLAVE: dieta mediterránea, salud cardiovascular, prevención, nutrición, riesgo

INTRODUCCIÓN

Actualmente, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, lo que ha llevado a un creciente interés por identificar factores modificables que permitan su prevención. Entre ellos, la alimentación ha adquirido un papel fundamental, ya que se ha demostrado que determinados patrones

dietéticos pueden influir de forma significativa en el desarrollo de estas patologías (Dinu et al., 2020).

En este contexto, la dieta mediterránea ha sido ampliamente reconocida como uno de los modelos alimentarios más saludables. Este patrón dietético, tradicional de países como España, Italia o Grecia, se caracteriza por un elevado consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales, junto con el uso del aceite de oliva como principal fuente de grasa. Además, incluye un consumo moderado de pescado, lácteos y vino, y una baja ingesta de carnes rojas y productos ultra procesados (Estruch et al., 2018).

Diversos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que las poblaciones que siguen este tipo de dieta presentan una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, así como una mayor esperanza de vida. Estos efectos beneficiosos se han atribuido tanto a la calidad de los alimentos como a la combinación de nutrientes presentes en este patrón dietético (Sofi et al., 2014).

Además, en los últimos años se ha puesto especial énfasis en el estudio de patrones dietéticos completos en lugar de nutrientes aislados, ya que los efectos sobre la salud dependen de la interacción entre los distintos componentes de la dieta (Willett et al., 2019). En este sentido, la dieta mediterránea destaca como uno de los modelos más completos, al combinar alimentos ricos en compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que contribuyen a la protección cardiovascular (Dinu et al., 2020; Guasch-Ferré y Willett, 2021).

Por otro lado, se ha observado que la adherencia a la dieta mediterránea no solo influye en la reducción del riesgo cardiovascular, sino también en la mejora de otros factores metabólicos, como la resistencia a la insulina o el control del peso corporal. Esto refuerza su papel como estrategia preventiva frente a enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 (Martínez-González et al., 2019).

Sin embargo, a pesar de la evidencia científica disponible, en los últimos años se ha producido una disminución en la adherencia a este patrón dietético, especialmente en población joven. Este cambio se ha relacionado con la globalización de los hábitos alimentarios y el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados (Guasch-Ferré y Willett, 2021).

Por todo ello, resulta relevante seguir analizando la evidencia científica disponible sobre los efectos de la dieta mediterránea en la salud cardiovascular.

El objetivo del presente trabajo es analizar la evidencia científica disponible sobre el impacto de la dieta mediterránea en la salud cardiovascular, así como evaluar su papel en la prevención de enfermedades crónicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha realizado una revisión bibliográfica centrada en la relación entre dieta mediterránea y salud cardiovascular.

Para ello, se han utilizado bases de datos como PubMed, ScienceDirect y Google Scholar, empleando palabras clave como “Mediterranean diet”, “cardiovascular risk” y “prevention”. Se han seleccionado principalmente artículos publicados en los últimos 10 años. Además, se priorizó la selección de artículos publicados en revistas de alto impacto, principalmente pertenecientes a Q1 en sus respectivas áreas según los índices de calidad científica. Esto permite asegurar la fiabilidad y relevancia de la información utilizada.

Se incluyeron estudios clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Se descartaron aquellos artículos que no abordaban directamente la relación entre dieta mediterránea y riesgo cardiovascular.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los estudios analizados coinciden en señalar que la dieta mediterránea ejerce un efecto protector frente a las enfermedades cardiovasculares, actuando sobre múltiples factores de riesgo de forma simultánea.

Uno de los trabajos más relevantes en este ámbito es el estudio PREDIMED, que demostró que la adherencia a una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos reduce de forma significativa la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, como infarto de miocardio, ictus o muerte de origen

cardiovascular (Estruch et al., 2018). Este estudio es uno de los más relevantes en cuanto al papel de la dieta como herramienta de prevención primaria.

En relación con el perfil lipídico, varios estudios han observado que este patrón dietético se asocia con un aumento de los niveles de colesterol HDL y una disminución del colesterol LDL, lo que contribuye a mejorar el equilibrio lipídico y reducir el riesgo de aterosclerosis (Sofi et al., 2014). Además, el consumo habitual de aceite de oliva, rico en ácidos grasos monoinsaturados, parece desempeñar un papel clave en este efecto.

Como se muestra en la tabla 1, la dieta mediterránea influye de manera positiva en diversos factores de riesgo cardiovascular.

Tabla 1. Principales efectos de la dieta mediterránea sobre la salud cardiovascular. Fuente: elaboración propia a partir de Estruch et al. (2018), Dinu et al. (2020) y Sofi et al. (2014).

Factor	Efecto observado
Colesterol HDL	Aumento
Colesterol LDL	Disminución
Presión arterial	Reducción
Inflamación	Disminución
Riesgo cardiovascular	Reducción global

Otro aspecto relevante es la reducción de la presión arterial en individuos con alta adherencia a la dieta mediterránea. Este efecto podría estar relacionado con el elevado contenido en potasio, antioxidantes y compuestos bioactivos presentes en frutas, verduras y legumbres (Dinu et al., 2020). La disminución de la presión arterial es especialmente importante, ya que constituye uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

Además, se ha observado una reducción de los marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, en personas que siguen este patrón dietético. La inflamación crónica de bajo grado está implicada en el desarrollo de la aterosclerosis, por lo que su disminución podría explicar parte de los beneficios cardiovasculares asociados a la dieta mediterránea (Guasch-Ferré y Willett, 2021).

Tal y como se observa en la figura 1, estos efectos se traducen en una reducción global del riesgo cardiovascular en un 30% en individuos con alta adherencia a este patrón dietético.

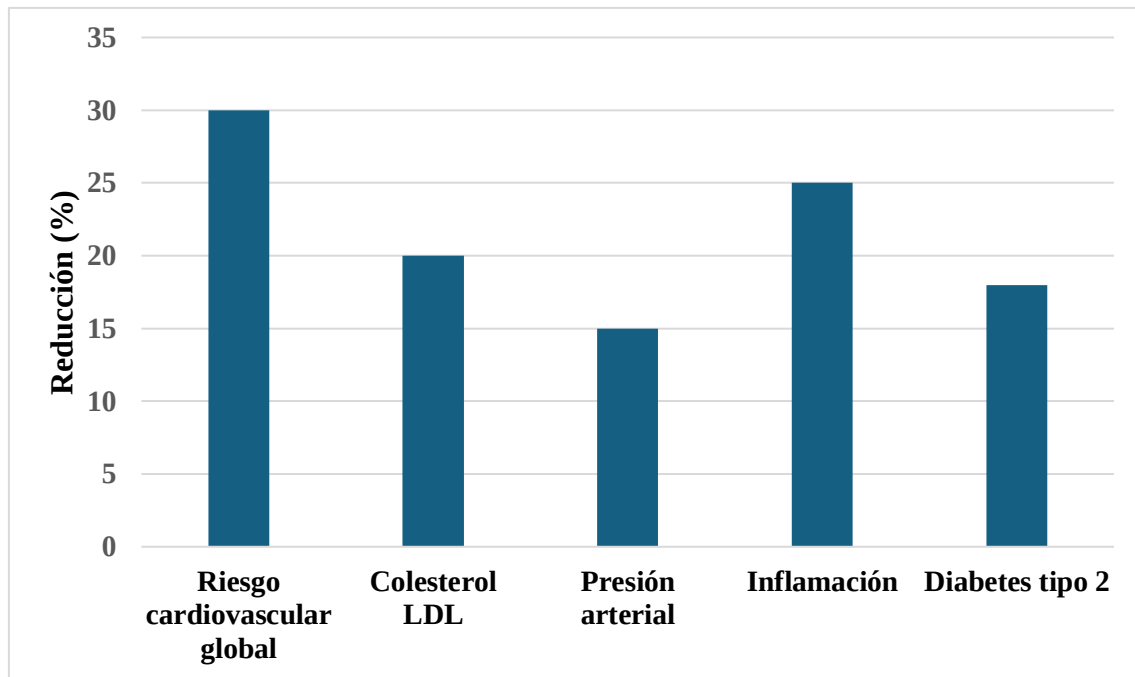


Figura 1. Efecto de la dieta mediterránea sobre factores de riesgo cardiovascular. Fuente: elaboración propia a partir de Estruch et al. (2018), Dinu et al. (2020) y Martínez-González et al. (2019).

Por otro lado, la dieta mediterránea también ha mostrado efectos positivos sobre el metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina, lo que se traduce en una menor incidencia de diabetes tipo 2 (Martínez-González et al., 2019). Este hecho refuerza su papel como estrategia preventiva global frente a enfermedades metabólicas.

En cuanto a los mecanismos implicados, se ha propuesto que los beneficios de la dieta mediterránea no se deben a un único nutriente, sino a la interacción de múltiples componentes, como los ácidos grasos monoinsaturados, los polifenoles, la fibra y los antioxidantes presentes en los alimentos que la componen. Esta sinergia podría explicar su efecto protector global (Willett et al., 2019).

A pesar de los beneficios descritos, es importante tener en cuenta algunas limitaciones. En primer lugar, muchos estudios se basan en cuestionarios de frecuencia alimentaria, lo que puede introducir sesgos. Además, la adherencia a la dieta puede variar en función de factores culturales, económicos o sociales, lo que dificulta la generalización de los resultados (Dinu et al., 2020).

En general, la evidencia científica revisada indica que la dieta mediterránea tiene un efecto beneficioso claro sobre la salud cardiovascular, ya que actúa de forma simultánea sobre distintos factores de riesgo como el perfil lipídico, la presión arterial y los procesos inflamatorios. Además, su relación con una menor incidencia de diabetes tipo 2 refuerza su papel como estrategia preventiva frente a enfermedades crónicas.

No obstante, es importante tener en cuenta que la adherencia a este patrón dietético ha disminuido en los últimos años, especialmente en población joven, lo que podría limitar su impacto a nivel poblacional. Por ello, resulta necesario promover este tipo de alimentación mediante intervenciones educativas y de salud pública.

En mi opinión, la dieta mediterránea no solo debe considerarse una pauta nutricional, sino un modelo de estilo de vida que puede contribuir de forma significativa a la mejora de la salud a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Dinu, M.; Pagliai, G.; Casini, A.; Sofi, F. 2020. Mediterranean diet and multiple health outcomes: an umbrella review. *BMJ* 370: m3029.

Estruch, R.; Ros, E.; Salas-Salvadó, J.; Covas, M.I.; Corella, D.; Arós, F.; et al. 2018. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. *New England Journal of Medicine* 378: e34.

Guasch-Ferré, M.; Willett, W.C. 2021. The Mediterranean diet and health: a comprehensive overview. *Journal of Internal Medicine* 290: 549-566.

Martínez-González, M.A.; Hershey, M.S.; Zazpe, I.; Trichopoulou, A. 2019. Transferability of the Mediterranean diet to non-Mediterranean countries. *Nutrients* 11: 1226.

Schwingshackl, L.; Hoffmann, G. 2017. Adherence to Mediterranean diet and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis. *BMJ* 357: j2197.

Sofi, F.; Macchi, C.; Abbate, R.; Gensini, G.F.; Casini, A. 2014. Mediterranean diet and health status: an updated meta-analysis. *BMJ* 349: g5686.

Willett, W.C.; Rockström, J.; Loken, B.; et al. 2019. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets. *The Lancet* 393: 447-492.